

一、单项选择题（1~20 题，每题 1 分，共 20 分）

1. B 2. D 3. A 4. A 5. D
6. B 7. D 8. C 9. A 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. C
16. A 17. D 18. A 19. B 20. C

二、多项选择题（21 — 30 题，每题 2 分，共 20 分）

21. A、C、E
22. A、B、C、D
23. A、B、C、D
24. A、B、C、D
25. A、C、E
26. C、D、E
27. A、C、E
28. A、B、C、D、E
29. A、B、C、D、E
30. A、B、C、E

三、填空题（31 — 45 题，每空 1 分，计 30 分）

31. 抑强、扶弱
32. 脾运化失职
33. 肝阳化风 热极生风 阴虚风动 血虚生风
34. 真热假寒证 真实假虚证
35. 督脉 膀胱经
36. 未病先防 既病防变
37. 以降为和 喜润恶燥
38. 足少阴肾经 足阳明胃经 足太阴脾经
39. 劳力过度 劳神过度 房劳过度
40. 因虚致实 虚中夹实
41. 伤寒 中寒
42. 悲 笑不休
43. 心 精
44. 精
45. 胆

四、名词术语解释（46~55 题，每题 3 分，共 30 分）

46. 阴阳互损，是指阴或阳的任何一方虚损到相当程度，病变发展影响及相对的一方（2 分），形成阴阳两虚的病机（1 分）。

47. 精血同源，即肝肾同源（1 分）。肝藏血，肾藏精，肝血和肾精存在相互资生、相互转化的关系，肾精可转化肝血，肝血可滋养肾精，故曰精血同源（2 分）。

48. 心肾相交，又称“水火既济”（1 分）。心在五行属火，肾在五行属水。心位居于上，肾位居于下。理论上认为心火必须下降于肾，肾水必须上济于心，这样，心肾之间的生理功能才能协调。心肾之间这种关系，称为“心肾相交”（2 分）。

49. 佐金平木，是滋肺阴、清肝火以治疗肝火犯肺病证的一种治疗方法，又称滋肺清肝火（2 分）。适用于肝火犯肺证（1 分）

50. 辨症求因，是指以病症的临床表现为依据，通过分析疾病的症状、体征来推求病因，为治疗用药提供依据(3分)。

51. 决渎之官，即三焦的别称(1分)。决即疏通之义，渎指水道。三焦为水液运行的通道，三焦通利，则水液运行畅通，故称决渎之官(2分)。

52. 汗、涕、泪、涎、唾五种分泌物或排泄物称之为五液。五液由五脏之精所化生并分属于五脏，故称为五脏化液，又称五脏化五液(2分)。分别为心在液为汗、肺在液为涕、脾在液为涎、肝在液为泪、肾在液为唾(1分)。

53. 阳盛格阴，是指邪热内盛，深伏于里。阳气被遏，郁闭于内。不能外达四肢而隔阴于外的一种病理状态(2分)，导致真热假寒证(1分)。

54. 阳病治阴，语出《素问·阴阳应象大论》，是一种针对虚热病症的治法。“阳病”，即指虚热证。因虚热证的病理机制是阴气虚衰不能制阳而导致阳气相对偏亢，故治宜滋阴抑阳，即王冰所谓“壮水之主，以制阳光”。

55. 阴中求阳，是根据阴阳互用理论而设的一种治法，即在补阳的基础上适当配以补阴药，使“阳的阴助而生化无穷”，适用于阳偏衰的虚寒证。

五、论述题(56~60题，每题10分，计50分)

56. 营气、卫气都是人体之气的组成部分，二者都由脾胃运化的水谷精微化生，此其同(2分)。二者的不同之处在于：①生成方面，营气由水谷精微中富含营养的成分化成，这种成分《内经》称为水谷之精气；卫气由水谷精微中活跃、流动迅速的成分生成，《内经》称之为水谷之悍气(2分)。②分布方面，营气运行于血脉之中，卫气运行于血脉以外(1分)。③功能方面，营气侧重于营养及化生血液，卫气侧重于温养皮肤、抵御外邪及调节腠理开合(2分)。

生理上，行于脉中的营气和行于脉外的卫气在功能上相互协调，人才能昼精夜瞑，抗邪能力强，体温正常，不会出现怕冷、发热的异常感觉(1分)。如果外邪侵犯人体，使卫气郁遏不宣(卫强)，营气相对不足(营弱)，即形成营卫不和(卫强营弱)。对此，《伤寒论》以桂枝汤进行治疗，桂枝针对卫强，宣发卫气的郁滞，芍药针对营弱，补益不足的营气(2分)。

57. 形态上，五脏为实质性脏器，六腑为空腔性脏器(1分)；功能上，五脏共同的功能是化生和贮藏精气，六腑的功能是受盛和传化水谷(2分)；生理特点上，五脏的生理特点为藏而不泻、满而不实，六腑的生理特点为泻而不藏，实而不满(2分)。根据五脏、六腑的功能特点，可以知道临床治疗。入五脏的主要功能是化生和贮藏精气，精气宜充满，不宜耗泄，故临床五脏病证以虚为多，治疗以补益为主(2分)。六腑的主要功能是受盛和传化水谷，水谷宜不断向下输送，保持消化道的通常，不宜在局部停滞，故临床六腑病症以实为多。根据六腑的生理功能特点，治疗六腑应该遵循“以通为用”的原则(2分)。应该指出的是五脏藏而不泻、六腑泻而不藏是相对而言的，事实上，五脏藏中有泻，六腑泻中有藏。临床上五脏病症也不是仅虚无实，六腑病症也不是仅实无虚。而是既有虚，又有实(1分)。

58. 扶正，是扶助机体的正气，增强体质，提高集体抗病、抗邪能力的一种治疗原则。祛邪，是祛除邪气，排除或削弱病邪侵袭和损害的一种治疗原则(2分)。

扶正和祛邪的应用原则是：①虚证宜扶正，实证宜祛邪，虚实错杂宜扶正祛邪并用；②应根据邪正盛衰及其在疾病过程中矛盾斗争的地位，决定其运用方式的先后与主次；③应注意扶正不留邪，祛邪不伤正(每条1分，计2分)。

扶正和祛邪在具体运用中，又有先后、主次之分。对于虚中夹实，应扶正为主，兼以祛邪（1分）；对于实中夹虚，应祛邪为主，兼以扶正（1分）；对于虚实并重，应扶正、祛邪并重（1分）。有时扶正、祛邪又有先后使用的情况。先祛邪后扶正，适用于①邪盛位主，兼扶正反会助邪，或虽有正虚但尚耐攻者；②正虚不甚，邪势方张，或微实微虚者，可先祛邪，邪气祛除则正气自复（1分）。先扶正后祛邪，适用于①正虚为主，机体不能耐受攻伐，兼祛邪易伤正者；②病情甚虚甚实，而病邪胶固不易扩散者（1分）。

59. 火热邪气与暑邪虽同属阳邪，皆具有火热之性及伤津耗气的致病特征（2分）。但二者仍存在一定的区别：①暑为夏季主气，乃火热之气所化，致病有明显的季节性，独见于夏季（2分）。火热之邪虽旺于夏季，但无明显的季节性，不受季节气候的限制，一年四季均可发生火热之证（2分）。②暑邪致病时，虽也可扰神和伤津耗气，但往往兼挟湿邪为患，既暑多挟湿（2分）；火热之邪致病常易生风动血和易致痈肿，又因火与心相应，致病多见扰动心神而出现神志异常的症状（2分）。

60. 答：肾精是有形的藏与肾中的精华物质，又禀受于父母的先天之精为主体，加之部分水谷之精的充养而成（2分）。肾气是由肾精化生的无形而运行不息的精微物质，与元气的概念相近，具有推动和调控人体的生长发育、生殖及脏腑气化等作用（2分）。肾精可化为肾气，肾气又可聚为肾精，两者可分不可离（1分）。肾气涵有阴阳两种成分：肾阳是其中具有温煦、推动、兴奋、宣散等作用的部分，又称为元阳、真阳，为一身阳气之根（2分）；肾阴是其中具有凉润、宁静、抑制、凝聚等作用的部分，又称元阴、真阴，为一身阴气之本（2分）。肾阴与肾阳对立同意，协调共济，则肾气冲和畅达（1分）。